

# Cholesterin: entscheidend ist dein Zielwert.

Einen Normalwert für alle gibt es nicht: Wie niedrig dein LDL sein sollte, hängt von deinem Gesamtrisiko ab. Hinten steht, was du tun kannst.

## 1 WAS IM BLUT GEMESSEN WIRD · NÜCHTERN NICHT NÖTIG



### LDL-Cholesterin

das Hauptziel jeder Behandlung



### Non-HDL

alle schädlichen Fette zusammen



### ApoB

zählt die Partikel, wichtig bei Diabetes und hohen Triglyceriden



### Lp(a)

erblich, pro Teilchen etwa 6 × so gefährlich wie LDL



### Triglyceride

steigen mit Zucker, Alkohol und Bauchfett

## 2 DEIN LDL-ZIEL IN MG/DL HÄNGT VOM RISIKO AB

| sehr hohes Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hohes Risiko  | moderates Risiko                                                                                                                                                                                                                                               | niedriges Risiko           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| unter 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unter 70      | unter 100                                                                                                                                                                                                                                                      | unter 116                  |
| ApoB unter 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ApoB unter 80 | ApoB unter 100                                                                                                                                                                                                                                                 | ApoB: kein Ziel festgelegt |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sehr hoch:</b> nach Herzinfarkt oder Schlaganfall, deutliche Plaques, Diabetes mit Organschaden.</li> <li><b>Hoch:</b> erblich stark erhöhtes Cholesterin, länger bestehender Diabetes, Nierenerkrankung. Ab hohem Risiko LDL zudem mindestens halbieren.</li> </ul> |               | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sonst</b> entscheidet der Risikorechner SCORE2 aus Alter, Geschlecht, Blutdruck, Rauchen und Cholesterin.</li> <li><b>Plaques</b> im Ultraschall oder CT und ein hohes Lp(a) heben dich eine Stufe höher.</li> </ul> |                            |

Dein LDL-Cholesterin

 mg/dl

Deine Risikogruppe

Dein Zielwert

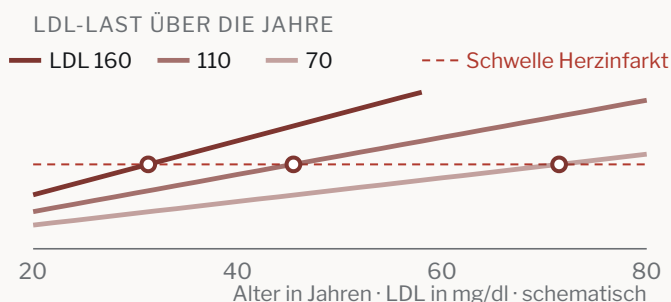
 mg/dl

## 3 LP(A): MINDESTENS EINMAL IM LEBEN MESSEN

|                     | unauffällig | Graubereich | erhöht   | sehr hoch |
|---------------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| in mg/dl            | unter 30    | 30–50       | über 50  | über 180  |
| in nmol/l, ungefähr | unter 75    | 75–105      | über 105 | über 430  |

**Pro Teilchen ist Lp(a) etwa sechsmal so gefährlich wie LDL.** Es ist zu etwa 90 % vererbt; ist es erhöht, senken wir alle anderen Risiken umso konsequenter.

## 4 WARUM FRÜH UND DAUERHAFT ZÄHLT



**Entscheidend ist die Menge über die Jahre.** Wer lebenslang ein niedrigeres LDL hat, erreicht die Schwelle für einen Herzinfarkt später oder nie.

–22 %

Herzinfarkte und Schlaganfälle je 39 mg/dl weniger LDL

1 von 5

hat ein erhöhtes Lp(a), meist unbemerkt

## 5 WAS DU SELBST TUN KANNST

Wirkung auf das LDL-Cholesterin nach ESC-Leitlinie. Zusammen, als pflanzenbetonte Portfolio-Kost, sank das LDL in Studien im Mittel um 17 %.

|                                                                                   |                                                                         |                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
|  | <b>Weniger gesättigte Fette</b><br>Wurst, fettes Fleisch, Butter, Sahne | <div><div></div><div></div><div></div></div> | deutlich |
|  | <b>Mehr lösliche Ballaststoffe</b><br>Hafer, Hülsenfrüchte, Flohsamen   | <div><div></div><div></div><div></div></div> | deutlich |
|  | <b>Übergewicht abbauen</b><br>besonders Bauchfett                       | <div><div></div><div></div><div></div></div> | deutlich |
|  | <b>Pflanzensterine</b><br>2 g täglich, z. B. angereicherte Margarine    | <div><div></div><div></div><div></div></div> | deutlich |
|  | <b>Transfette meiden</b><br>Frittiertes, Blätterteig, Fertiggebäck      | <div><div></div><div></div><div></div></div> | deutlich |
|  | <b>Mehr Bewegung</b><br>wirkt vor allem auf Triglyceride und HDL        | <div><div></div><div></div><div></div></div> | gering   |

Nahrungsergänzungsmittel ohne belegte Wirkung und Sicherheit empfiehlt die ESC ausdrücklich nicht. Triglyceride sinken vor allem mit weniger Alkohol und Zucker.

## 6 WANN MEDIKAMENTE DAZUKOMMEN

Bei sehr hohem Risiko sofort zusammen mit dem Lebensstil, sonst wenn der Zielwert nach einigen Monaten nicht erreicht ist. Das Prinzip: **so niedrig wie nötig, so früh wie sinnvoll.**

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statin</b>            | → Grundlage. Senkt das LDL je nach Dosis um 30 bis über 50 %, schützt nachweislich.   |
| <b>+ Ezetimib</b>        | → Hemmt die Aufnahme im Darm: weitere 20 bis 25 %, oft in einer Tablette.             |
| <b>+ PCSK9-Hemmung</b>   | → Spritze alle zwei bis vier Wochen oder zweimal im Jahr, wenn das Ziel sonst fehlt.  |
| <b>Unverträglichkeit</b> | → Oft hilft ein anderes Statin oder weniger Dosis; sonst Bempedoinsäure oder Spritze. |

## 7 KONTROLLE

Sechs bis acht Wochen nach Beginn oder Änderung einer Therapie, danach einmal im Jahr. Lp(a) mindestens einmal im Leben.

|          | DATUM | LDL | APOB | LP(A) | ZIEL? |
|----------|-------|-----|------|-------|-------|
| Start    |       |     |      |       |       |
| 8 Wochen |       |     |      | -     |       |
| 1 Jahr   |       |     |      | -     |       |

## 8 DEINE ERSTEN SCHRITTE

- ☐ Lp(a) mindestens einmal im Leben bestimmen lassen
- ☐ Risikogruppe und Zielwert mit mir festlegen
- ☐ Butter und Wurst durch Olivenöl, Nüsse, Hülsenfrüchte ersetzen
- ☐ \_\_\_\_\_

## 9 PASSENDE HANDOUTS

|                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Ernährung</b><br>Fette tauschen |  <b>Blutdruck</b><br>Messen und senken |  <b>Zucker und Niere</b><br>HbA1c,<br>Glukosekurve |  <b>Ausdauer</b><br>VO <sub>2</sub> max, Zonen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Fragen? Vereinbare einen Termin bei mir.**

Praxis KardioPro · Im Neuen Stahlhof · Breite Straße 69 · 40213 Düsseldorf  
**0211 54 55 66 46 · bruno@kardio.pro · kardio.pro**

Quellen: Mach F et al., 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias, Eur Heart J 2020 · Mach F et al., 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines, Eur Heart J 2025 · Kronenberg F et al., EAS Consensus Statement Lipoprotein(a), Eur Heart J 2022 · Cholesterol Treatment Trialists, Lancet 2010 · Ference BA et al., Eur Heart J 2017 · Chiavaroli L et al., Prog Cardiovasc Dis 2018 · Björnson E et al., J Am Coll Cardiol 2024.